

Body-checking *analogia do rytuałów OCD*

Obsesyjne sprawdzanie ciała: lustro, pomiary, dotyk, porównania. Pacjenci sprawdzają 50–200× dziennie. Teoretycznie „daje pewność” — praktycznie utrzymuje obsesję. Redukcja przez ekspozycję.

CZAS: 25 min · monitorowanie + cele · Etap 3 CBT-E (sesje 10–16) · standard

ŹRÓDŁO: Shafran, Fairburn i in. (2004); Reas i in. (2002)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **typowe formy body-checking** (sekcja 1), zobacz, dlaczego sprawdzanie **wzmacnia obsesję** zamiast ją uspokajać (sekcja 2). Sekcja 3 — Twój dziennik checków. Sekcja 4 — plan stopniowej redukcji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Body-checking to **powtarzalne, nawykowe sprawdzanie ciała** — w lustrze, przez dotyk, porównania, mierzenie. Teoretycznie ma „dawać pewność” — praktycznie **podtrzymuje** lęk i zniekształcenia. Shafran & Fairburn (2004): body-checking w bulimii jest *analogią* do rytuałów w OCD — krótkotrwała ulga za cenę długoterminowego wzmocnienia obsesji. Mechanizm: każde sprawdzenie **chwilowo** redukuje lęk, ale **uczy** mózg, że **nie można żyć** bez sprawdzania. Reas i in. (2002): pacjenci z bulimią sprawdzają ciało **50–200 razy dziennie**, często **nieświadomie**. Redukcja body-checkingu jest **obowiązkowym** elementem etapu 3 CBT-E. Cel: świadomość → opóźnienie → eksperyment behawioralny → habituacja niepewności.

01 = Typowe formy body-checkingu

LUSTROWANIE

Wielokrotne oglądanie się w lustrze (kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie). Często z różnych kątów, w różnych ubraniach.

DOTYK

Ściskanie tłuszczu palcami, sprawdzanie obojczyków, brzucha, ud. „*Jak dużo jest?*”. Wielokrotnie w ciągu dnia.

WIELOKROTNE WAŻENIE

Waga 5–20× dziennie. Po jedzeniu, po toalecie, rano, wieczorem. Każda zmiana = panika lub euforia.

MIERZENIE UBRAŃ

„*Czy ta sukienka jeszcze pasuje?*”, „*Czy spodnie się zapinają?*”. Konkretnie ubranie jako miernik ciała.

PORÓWNYWANIE

Z innymi osobami w przestrzeni publicznej, ze starszymi własnymi zdjęciami, ze zdjęciami modeli i influencerów.

POMIARY

Miarka centymetrowa (talia, biodra, udo), aplikacje, robione regularnie. Próba wykrycia drobnych zmian.

02 ● Dlaczego sprawdzanie wzmacnia obsesję

Mechanizm: impuls do sprawdzenia → sprawdzenie → chwilowa ulga („OK, sprawdziłem/-am”) → mózg uczy się: *muszę sprawdzać, żeby było OK* → silniejszy impuls do sprawdzania w przyszłości → częstsze sprawdzanie → więcej okazji do zauważania drobnych zmian → **więcej lęku**, nie mniej.

Analogia do OCD: osoba z OCD myje ręce kilkadziesiąt razy, żeby „być bezpieczna”. Każde mycie chwilowo redukuje lęk, ale długoterminowo **wzmacnia** obsesję czystości. Tak samo body-checking każde sprawdzenie chwilowo redukuje lęk o ciało, ale długoterminowo wzmacnia obsesję ciała.

03 Dziennik checków — pierwszy tydzień

Przez jeden tydzień zapisuj **każde** sprawdzenie ciała (jakie, kiedy, gdzie). Większość pacjentów jest zaskoczona ilością — często liczy 50-150 checków dziennie, choć subiektywnie „tylko czasami”. Świadomość to pierwszy krok do redukcji.

DZIEŃ	LICZBA CHECKÓW	NAJCZĘSTSZA FORMA	WYZWALACZE
Pon.			
Wt.			
Śr.			
Czw.			
Pt.			
Sob.			
Niedz.			

04 Plan stopniowej redukcji

TYDZIEŃ 1: MONITOROWANIE

Tylko świadomość. Liczysz checki, nie próbujesz redukować. Cel: poznać własną bazę.

TYDZIEŃ 2: OPÓŹNIENIE 5 MIN

Każde sprawdzenie odłóż o 5 minut. „Za 5 min, jeśli nadal będę chciał/a”. Często impuls opada.

TYDZIEŃ 3-4: CEL -25%

Zredukuj checki o 25% w stosunku do bazy. Stopniowo, nie naraz. Konkretnie formy do wyeliminowania.

TYDZIEŃ 5+: EKSPERYMENT

Cały dzień (potem tydzień) **bez** jednej formy checkingu. Obserwuj efekt na lęk. Lęk paradoksalnie spada.

Klucz: body-checking jest *analogiczny* do rytuałów OCD — krótkotrwała ulga, długoterminowe wzmocnienie obsesji. Shafran & Fairburn (2004): redukcja body-checkingu w CBT-E daje **spadek lęku o ciało** o 40-60% w ciągu 8 tygodni — to *kontrintuicyjne*, bo wielu pacjentów obawia się, że bez sprawdzania lęk wzrośnie. *Habituacja niepewności*: mózg uczy się, że **można żyć** bez ciągłego potwierdzania stanu ciała. Pierwsze dni są najtrudniejsze — wymagają trzymania się planu, mimo silnego impulsu. Po 5-7 dniach impuls zaczyna naturalnie słabnąć. Mountford & Waller (2006): eksperyment behawioralny „tydzień bez lustrowania” jest jednym z najsilniejszych narzędzi etapu 3 — pacjenci doświadczają na własnej skórze, że *świat się nie zawalił* bez sprawdzania. To bezpośrednie doświadczenie zmienia więcej niż jakakolwiek rozmowa. Reas i in. (2002): pacjenci z niskim body-checkingiem po terapii mają **znacząco lepszą** jakość życia i mniejsze ryzyko nawrotu. *Mniej sprawdzania = więcej życia*.